

Что лежит в основе остеопороза? {

~увеличение количества костного вещества в единице объёма костей

=уменьшение количества костного вещества в единице объёма кости

~косо-идущие в кости полосы просветления

~поперечно-идущие в кости полосы просветления

}

Что лежит в основе гипостоза? {

~разрушение кости

=уменьшение объёма кости

~недостаточное образование костной ткани во время развития скелета

~увеличение объёма кости

}

Что лежит в основе остеонекроза? {

~увеличение размеров кости

=омертвление костной ткани

~уменьшение объёма кости

~увеличение объёма кости

}

Как на рентгенограмме выглядит секвестр? {

~участок уплотнения кости

~участок разрушения кости

~дефект кости с нечеткими контурами

=участок уплотнения на фоне дефекта

}

Деструкция-это: {

~утолщение кости

=разрушение костной ткани

~разрежение костной ткани

~уплотнение костной ткани

}

Атрофия-это: {

~уменьшение количества костных балок в единицу объёма кости;

~разрушение костной ткани;

=уменьшение костного вещества вместе с уменьшением объёма кости;

~уплотнение костной ткани

}

Назовите виды периостальной реакции воспалительного генеза: {

~%50%отслоенный

~%50%бахромчатый

~%-50%игольчатый

~%-50%козырьковый

}

Назовите виды периостальной реакции опухолевого генеза: {

~%-50%бахромчатый

- ~%50%игольчатый
- ~%-50%отслоенный
- ~%50%козырьковый

}

Гиперостоз- это: {

- ~утолщение кости с уменьшением костного вещества
- ~утолщение кости с периостальной козырьковой реакцией
- =утолщение кости со склерозом
- ~увеличение количества костных балок в единицу объема кости

}

Остеосцинтиграфия при злокачественных новообразованиях дает: {

- = «горячий» очаг
- ~ «холодный» очаг
- ~неравномерное накопление РФП
- ~накопление в зонах роста

}

Назовите количественные способы определения минерализации скелета: {

- ~однофотонная абсорбциометрия
- ~двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия
- ~резонансная томография
- ~остеосцинтиграфия
- =рентгеновская остеоденситометрия

}

Радионуклидное исследование (сцинтиграфия) при остеомиелите дает

- =горячий очаг;
- ~холодный очаг;
- ~равномерное распределение РФП
- ~накопление РФМ в печени

}

В течение какого времени появляются рентген-признаки после начала остеомиелита? {

- =к концу 4-ой недели
- ~к концу 20-ой недели
- ~через 3 месяца
- ~через 2 месяца

}

Назовите ранние рентгенологические признаки остеомиелита: {

- =локальный остеопороз
- ~секвестр
- =мелкие деструктивные очаги
- ~крупные деструктивные очаги

}

Какая периостальная реакция при остеомиелите: {

- ~%50%бахромчатый периостит
- ~%-50%козырьковый периостит

~%50%спикулообразный периостит

~%50%линейный

}

Назовите рентгенологические признаки остеомиелита в фазе разгара болезни:

{

~%50%деструкция

~%50%секвестрация

~%50%периостальные наслоения

~%50%остеосклероз

}

Назовите рентгенологические признаки остеомиелита в стадии затихания болезни: {

~%50%остеопороз

~%50%остеосклероз

~%50%деструкция

~%50%гиперостоз

}

Какой отдел кости поражается при туберкулезе: {

~%50%эпифиз

~%50%метафиз

~%50%диафиз

~%50%апофиз

}

Какой метод радионуклидной диагностики применяют для визуализации скелета: {

~радиометрия

~радиография

=сцинтиграфия

~радионуклидный микроанализ

}

Какой отдел трубчатых костей участвует в образовании сустава? {

~диафиз

=эпифиз

~метафиз

~апофиз

}

Назовите контрастные методы исследования костей и суставов: {

~%50%томография

~%50%рентгенография

~%33,33333%фистулография

~%33,33333%ангиография

~33,33333%артрография

}

Как распределяется РФП в костной системе здорового человека

~неравномерно и несимметрично

=равномерно с относительным накоплением в зонах роста
~светлая полоска эпиметафизарного хряща
~неравномерно

}

В чем преимущество КТ костей ? {

~выявляется изображение только мягких тканей
~изображение костей, суставов и сосудов
=изображение костей и суставов в аксиальной проекции
~изображение костей и суставов в сагиттальной проекции

}

УЗИ костной системы применяется для исследования? {

~%50%опухолей костей
~%50%разрывов сухожилий
~%50%абсцессов и гематом мягких тканей
~%50%переломов костей

}

Какие РФП используются для радионуклидной визуализации скелета: {

~%100%¹³¹йод
~%50%^{99m}Tc- пирофосфат
~%50%^{99m}Tc- дифосфонат

}

Назовите основные рентгенологические признаки дистрофического поражения сустава: {

~%100%расширение суставной щели
~%33,3333%сужение рентгеновской суставной щели
~%33,3333%уплотнение замыкательной пластинки эпифизов
~%33,3333%субхондральный склероз

}

Радионуклидное исследование (остеосцинтиграфия) при болезни Пертеса: {

~«холодный очаг»
~«горячий очаг»
=неравномерное накопление РФП
~накопление РФП в печени

}

Назовите рентгенологические признаки доброкачественных опухолей костей:

{

~%33,3333%правильная форма
~%33,3333%четкие контуры
~%100%деструктивные очаги
~%33,3333%узкое основание

}

Назовите рентген признаки остеолитической остеогенной саркомы: {

~%50%деструкция
~%50%периостальные козырьки
~%50%секвестр

~%-50%отслоенный периостит

}

Назовите основной рентген-признак саркомы «Юинга»: {

~деструкция преимущественно в эпифизе

~деструкция преимущественно диафиза

~бахромчатый периостит

=слоистый периостит

}

В каких случаях применяется магнитно-резонансная томография? {

~при переломах

~для исследования костного мозга

~для изучения активности минерального обмена в костной ткани

=для исследования мягких тканей и сосудов

В чем заключается компьютерная томография? {

=это метод послойного рентгенологического исследования

~это фотографирование изображения с флюоресцентного экрана

~это исследование с применением электронно-оптического преобразования

~это исследование с применением электронно-оптического преобразования

}

К какому году завершается процесс окостенение скелета? {

~к 18 годам

=к 25 годам

~к 35 годам

~к 50 годам

}

Как выглядит на рентгенограмме у новорожденных рентгеновская суставная щель? {

~не прослеживается

~смещена

~сужена

=расширена

}

Назовите основной метод рентгенологического исследования костей и суставов: {

~рентгеноскопия

=рентгенография

~фистулография

~артрография

}

Изображение на рентгенограмме дают следующие структуры кости: {

=костные балки и трабекулы

~надкостница

~костный мозг

~хрящ

}

Какие отделы кости состоят преимущественно из губчатого вещества? {

~%50%диафиз

~%50%костномозговой канал

~%50%метафиз

~%50%эпифиз

}

Апофиз - это: {

~межмышечковые возвышения

~рентгеновская суставная щель

=выступ кости вблизи эпифиза, имеющий самостоятельное ядро окостенения

~преимущественно в диафизах

}

Назовите основные рентгенологические признаки переломов: {

~%50%наличие линии перелома

~%50%смещение отломков

~%50%периостальная реакция

~%50%наличие линии затемнения

}

Какие переломы наблюдаются в детском возрасте? {

~%33,33333%эпифизеолиз

~%33,33333%поднадкостничные переломы

~%33,33333%неполные переломы

~% - 100%патологические переломы

}

Как на сцинтиграмме определяется перелом? {

~холодный очаг

~неравномерное скопление РФП

=горячий очаг

~равномерное распределение РФП

}

Назовите стадии образования костной мозоли: {

~%33,33333%остеоидная

~%100%перепончатая

~%33,33333%соединительно-тканная

~%33,33333%костная

}

Назовите первую стадию образования костной мозоли: {

~остеоидная

=соединительно-тканная

~костная

~перепончатая

}

За какой срок происходит полное образование первичной костной мозоли? {

=за один год;

~за 2-5 месяцев;

~за один месяц

~за 6 месяцев

}

Назовите рентгенологические признаки развития ложного сустава: {

~%50%отсутствие костной мозоли

~%50%заращение костномозгового канала на концах отломков и образование по их краю замыкающей костной пластинки

~%-50%наличие костной мозоли

~%-50%наличие линии просветления

}

Назовите основные рентгенологические признаки вывихов: {

~%50%отсутствие головки в суставной впадине

~%50%полное несоответствие суставных концов костей

~%-50%наличие клиновидной формы рентгеновской суставной щели

~%-50%наличие линии просветления

}

Перечислите рентгенологические признаки заболеваний с уменьшением костной ткани: {

~%25%атрофия

~%25%остеопороз

~%25%деструкция

~%25%остеонекроз

~%-100%остеосклероз

}

Перечислите изменения надкостницы при воспалительных заболеваниях: {

~%50%отслоенный

~%50%бахромчатый

~%-33,33333%козырьковый

~%-33,33333%сникулообразный

~%-33,33333%слоистый

}

Перечислите рентгенологические признаки заболеваний с увеличением костной ткани: {

~%33,33333%гипертрофия

~%33,33333%остеосклероз

~%33,33333%периостоз

~%-100%остеопороз

}

Что определяют с помощью ультразвуковой биолокации? {

~наличие деструктивных очагов

~количественное измерение минерализации скелета

=периостальную реакцию

~наличие перелома

}

В каких случаях наиболее информативна МРТ? {

- ~при сложных переломах
- ~при некрозах и инфарктах костного мозга
- =при абсцессах мягких тканей
- ~при смещениях костных отломков

}

Назовите основные формы остеопороза: {

- ~%33,33333%местный
- ~%33,33333%регионарный
- ~%33,33333%распространенный
- ~%-100%идиопатический

}

В каких случаях возникают лооzerовские зоны перестройки? {

- =когда кость подвергается чрезмерной нагрузке,
- ~при воспалительных заболеваниях костей,
- ~при опухолях
- ~при абсцессах

}

Эпифизеолиз - это: {

- ~внутрисуставной перелом
- =травматическое отделение эпифиза кости от метафиза,
- ~патологический перелом
- ~смещение отломков

}

Какой признак является специфичным при газовой гангрене: {

- =появление газовых пузырьков и расслоение мышечных волокон
- ~периостит
- ~деструктивные очаги в костях
- ~остеосклероз

}

Перечислите методы лучевого исследования применяемые при травме костно-суставной системы: {

- ~%-50%КТ
- ~%50%рентгенография
- ~%50%электрорентгенография
- ~%-50%УЗИ костей

}

В каких случаях и с какой целью при травме костно-суставной системы используют КТ? {

- =в дифференциальной диагностике травматического и патологического компрессионного перелома позвоночника
- ~для выявления линий перелома при травме трубчатой кости
- ~для определения смещений обломков трубчатых костей
- ~для определения костной мозоли

}

Перечислите правила рентгенографии костно-суставной системы при травме:

- {
- ~%50%рентгенография всей повреждённой области
- ~%-50%рентгенография в прямой проекции
- ~%50%рентгенография в двух взаимно перпендикулярных проекциях
- ~%-50%рентгенография в боковой проекции

}

Перечислите признаки костного компрессионного перелома позвонка: {

- ~%33,33333%снижение высоты позвонка
- ~%33,33333%изменение формы позвонка
- ~33,33333%клиновидная деформация позвонка
- ~%-100%линия перелома

}

Перечислите этапы проведения рентгенографии при неосложнённом переломе кости: {

- ~%-100% каждые 12 часов после репозиции обломков
- ~%25%при поступлении в травм пункт
- ~%25%после репозиции обломков
- ~%25%после смены гипсовой повязки
- ~%25%после 32 - 35 -го дня нефиксированных обломков

}

Перечислите признаки, характерные только для огнестрельного перелома трубчатой кости: {

- ~наличие линии перелома
- ~наличие большого количества осколков
- ~смещение обломков
- =наличие инородных металлических тел в кости и окружающих тканях

}

Наиболее характерный признак костного анкилоза: {

- ~отсутствие суставной щели
- =костные балки переходят с одного суставного конца на другой
- ~наличие остеосклероза в суставных концах костей
- ~наличие остеопороза в суставных концах костей
- ~периостоз в суставных концах костей

}

Основной дифференциально - диагностический признак ложного сустава: {

- ~сохранение линии перелома
- ~отсутствие костной мозоли
- ~расположение обломков под углом
- =формирование замыкательных пластинок на концах костных обломков
- ~наличие зоны перестройки в обломках кости

}

Статическую сцинтиграфию целесообразно использовать: {

- ~%-100% для определения перелома косо-суставной системы
- ~%33,33333%для выявления метастазов злокачественных опухолей в кости

~%33,33333%для оценки распространенности метастатического процесса
~%33,33333%для оценки активности воспалительного процесса в суставах
}

При заболеваниях позвоночника КТ целесообразно использовать: {

~%33,33333%для выявления метастазов опухоли в тела позвонков
~%33,33333%для дифференцировки травматического и патологического
компрессионного перелома тела позвонка
~%-100%для определения сколиоза
~%33,33333%для выявления костных экзофитов, суживающих костно-
мозговой канал
}

Ангиографию костно-суставной системы целесообразно использовать: {

~для выявления секвестров
~выявления острого гематогенного остеомиелита
~для выявления хронического гематогенного остеомиелита
=при остеогенной опухоли для определения степени вовлечения в процессе
мягких тканей
}

УЗИ при заболеваниях костей и суставов используют: {

~для установления злокачественного характера опухоли кости
~для оценки состояния межпозвоночных хрящей при остеохондрозе
~для оценки состояния суставной щели при костном анкилозе
=для оценки состояния параоссальных тканей при остеомиелите
}

Остеопороз - это: {

=разрежение кости
~уплотнение кости
~рассасывание кости
~разрушение кости
~утолщение кости
}

Остеосклероз - это: {

~разрежение кости
=уплотнение кости
~рассасывание кости
~разрушение кости
~утолщение кости
}

Гиперостоз - это: {

~разрежение кости
~уплотнение кости
~рассасывание кости
~разрушение кости
=утолщение кости
}

Деструкция кости - это: {

- ~разрежение кости
- ~уплотнение кости
- ~рассасывание кости
- =разрушение кости
- ~утолщение кости

}

Остеолизис - это: {

- ~разрежение кости
- ~уплотнение кости
- =рассасывание кости
- ~разрушение кости
- ~утолщение кости

}

Рентгенография: вырост на ножке, отсутствие изменений структуры кости

Сцинтиграфия с ⁹⁹м Тс пирофосфатом: накопление РФП не повышено: {

- ~острый гематогенный остеомиелит
- ~хронический гематогенный остеомиелит
- =доброкачественная опухоль
- ~злокачественная опухоль
- ~дегенеративно-дистрофическое поражение суставов

}

Рентгенография: остеосклероз, периостальные наслоения, деструкция: {

- ~острый гематогенный остеомиелит
- =хронический гематогенный остеомиелит
- ~доброкачественная опухоль
- ~злокачественная опухоль
- ~дегенеративно-дистрофическое поражение суставов

}

Рентгенография: отслоенный периостит, деструкция в метафизе кости,

экссудат в периостальных тканях: {

- =острый гематогенный остеомиелит
- ~хронический гематогенный остеомиелит
- ~доброкачественная опухоль
- ~злокачественная опухоль
- ~дегенеративно-дистрофическое поражение суставов

}

Рентгенография: деструкция костной ткани, разрушение коркового слоя, слоистые обызвествления надкостницы, игльчатый периостоз: {

- ~острый гематогенный остеомиелит
- ~хронический гематогенный остеомиелит
- ~доброкачественная опухоль
- =злокачественная опухоль
- ~дегенеративно-дистрофическое поражение суставов

}

Рентгенография: сужение суставной щели, костные разрастания по краям суставных поверхностей, деформация суставных поверхностей, субхондральный склероз и кистовидные образования суставных концов костей: {

~острый гематогенный остеомиелит

~хронический гематогенный остеомиелит

~доброкачественная опухоль

~злокачественная опухоль

=дегенеративно-дистрофическое поражение суставов

}

Соединения между рёбрами и грудиной - это: {

~синдесмозы

=синхондрозы

~суставы

~синостозы

}

У первого шейного позвонка отсутствуют: {

=тело

~дуга

~боковые массы

~поперечные отростки

}

Наиболее убедительными симптомами при распознавании переломов костей является: {

~уплотнение костной структуры

~деформация кости

=перерыв коркового слоя

~линия затемнения

}

Для переломов шейки бедренной кости не характерны: {

~смещение по длине с захождением отломков

~ротация наружу

=ротация внутрь

~смещение по углам открытым внутрь

}

Для оскольчатого разрывного перелома поясничных позвонков не характерно:

{

=клиновидная деформация тела

~разрыв обеих замыкающих пластинок

~снижение высоты прилежащего межпозвоночного диска

~остеосклероз замыкающих пластинок

}

Рентгенологическими симптомами травматического повреждения межпозвоночного диска являются: {

=расширение межпозвоночного пространства

~сужение межпозвоночного пространства

~смещение вышележащего позвонка

~снижение высоты тела позвонка

}

Наиболее ранними проявлениями костной мозоли при диафизарных переломах является: {

=облаковидная параоссальная тень

~сглаженность краев отломков

~уплотнение краев отломков

~смещение отломков

}

Наиболее убедительно свидетельствует о несрастающемся переломе: {

~отсутствие параоссальной мозоли

~длительно прослеживающаяся линия перелома

=склеротическое отграничение краев отломков

~снижение плотности костных отломков

}

Для ложного сустава не характерны: {

~сглаженность и закругленность концах отломков

~склероз по краям отломков

~длительно прослеживающаяся щель между отломками

=зазубренность концов отломков

}

Отсутствие рентгенологических изменений со стороны костно-суставного аппарата в первые 2-3 недели с последующей быстрой динамической рентгенологической картиной характерно: {

=для острых неспецифических процессов

~для туберкулёзных поражений

~для сифилиса

~для переломов детского возраста

}

Изменение кости и надкостницы при гематогенной остеомиелите у взрослых появляются в сроки: {

~7-10 дней

=2-3 недели

~1-1,5 месяца

~2 месяца

}

Гиперостоз характерен: {

~для туберкулёза

~для подострой стадии остеомиелита

=для хронической стадии остеомиелита

~для болезни Пертеса

}

Костной секвестр рентгенологически характеризуется:

=повышением интенсивности тени

~уменьшением интенсивности тени

~частичном отграничении от окружающей костной ткани

}

Туберкулёзный остит чаще возникает: {

=в эпифизе

~в метафизе

~в диафизе

~в апофизе

}

Для туберкулеза наиболее характерны секвестры: {

=губчатые

~кортикальные

~тотальные

~кортикальные и тотальные

}

Чаще всего поражаются сифилисом: {

~позвонки

~бедренные кости

=большеберцовые кости

~тазовые кости

}

Злокачественным опухолям костей преимущественно поражающие лиц старше 50 лет относятся: {

~остеогенная саркома

=хондросаркома

~ратикуло саркома

~саркома Юинга

}

Слоистые периостальные реакции наиболее характерны: {

~для остеогенной саркомы

~для хондросаркомы

=для саркомы Юинга

~остеомиелита

}

Для лучевой диагностики перелома кости целесообразно применить: ?{

=рентгеновское исследование

~ультразвуковое исследование

~радиоизотопное исследование

~магнитно-резонансную томографию

}

Рентгенографию костей и суставов необходимо проводить в:

~прямой проекции

~косой проекции

=двух взаимно перпендикулярных проекциях
~в боковой проекции
}

На рентгенограммах неизменённой кости определяется надкостница: {
~в эпифизе
~в метафизе
=не определяется
~в диафизе

Перечислите методы лучевого исследования, применяемые при травме костно-суставной системы: {
~%50%магнитно-резонансная томография
%50%рентгенография
~%50%электрорентгенография
~%50%ультразвуковое исследование
}

В каких случаях при травме костно-суставной системы используют МРТ: {
~для выявления линии перелома в трубчатой кости
~для дифференциальной диагностики патологического перелома позвонка
=при переломе тела и дуги позвонка для выявления с давления обломками спинного мозга и его корешков
~для определения костной мозоли
}

В каких случаях при травме костно-суставной системы не используют электрорентгенографию: {
=при массовых травматических повреждениях
~для оценки произведённой репозиции
~для контроля мозолеобразования
~для выявления посттравматических осложнений
}

При повреждении мениска и круглой связки в коленном суставе наиболее информативны: {
~рентгенография
~продольная томография
~компьютерная томография
=магнитно-резонансная томография
}

Наиболее ранним рентгенологическим признаком гематогенного остеомиелита являются: {
~%50%мелкоочаговая деструкция
~%50%остеосклероз
~%50%деструкция
~%50%периостальная реакция
}

Наиболее частым осложнением гематогенного остеомиелита является: {

~эпифизеолиз
~гнойный артрит
~озлокачествление
=свищ

}

Для доброкачественных опухолей и внутрикостной локализации наиболее типичны: {

~нечёткие очертания
=чёткие очертания
~склеротический ободок
~широкий склеротический вал

}

Для хронического остеомиелита характерны: {

~%50%остеосклероз
~%50%секвестры
~%-50%деструкции
~%-50%изменения в мягких тканях

}

Для злокачественной опухоли кости наиболее характерной является периостальная реакция, проявляющаяся в виде: {

~линейной тени
~слоистого периостального наслоения:
=периостального козырька
~бахромчатого периостита

}

Опухолевое костеобразование имеет место при: {

=остеогенной саркоме
~саркоме Юинга
~миеломе
~ туберкулёзном поражении

}

На злокачественное поражение кости указывает: {

~%50%периостальный козырёк в виде спикул
~%-50%пластинчатая периостальная реакция
~%50%беспорядочная оссификация в мягких тканях в виде пятнистых и хлопьевидных теней
~%-50%уплотнение костной структуры

}

Раннее выявление метастатического поражение костей возможно с помощью:

{

~обычной рентгенографии
~томографии
=сцинтиграфия
~рентгенографии с прямым увеличением изображения

}

Рентгеновская оценка суставов у детей раннего возраста затруднена, так как:

- {
- ~ребёнок имеет малые размеры тела
- ~ребёнок имеет малую массу тела
- =неоссифицированные эпифизы
- ~ребенок двигается
- }

На этапах лечения перелома рентгенологический контроль проводится для: {

- ~подтверждения наличия перелома
- =обнаружения вторичного смещения отломков и оценки костной мозоли
- ~вживления компрессии нервных стволов гематомы в зоне перелома
- ~по желанию родителей
- }

Эхографически можно визуализировать: {

- ~%33,33333%ушибы подкожной клетчатки
- ~%33,33333%повреждения сухожилий
- ~%33,33333%повреждений мягких тканей
- ~%-100%переломы костей
- }

Косвенные эхо признаки остеомиелита появляются: {

- =ранее рентгенологически
- ~позже рентгенологически
- ~одновременно с рентгенологически
- ~возможен любой вариант
- }

При патологических изменениях тазобедренного сустава эхографически определяется: {

- ~33,33333%уплощение костной части вертлужной впадины
- ~%-100%внутрисуставной перелом
- ~%33,33333%расширение хрящевой крыши сустава
- ~%33,33333%смещение головки бедра латеральном и краниальном направлении
- }

Назовите рентгенологические признаки начальной стадии болезни «Пертеса»:

- {
- ~%33,33333%остеопороз головки бедра кости
- ~%33,33333%уплощение головки
- ~%-100%наличие свирепого хода
- ~%33,33333%расширение суставной щели
- }

Что такое эпифизиолиз: {

- ~вывих в суставе
- =отделение эпифиза по ростковой зоне
- ~неполный перелом
- ~поднадкостный перелом

}

Какая методика наиболее информативна при повреждении менисков: {

~рентгенограмма в 2 проекциях

~УЗИ исследование

~сцинтиграфия

=МРТ

}

Лучевой контроль состояние кости при остеомиелите проводится: {

=рентгенологически

~УЗИ

~КТ

~не проводится

}

Рентгенологическое повышение воздушности лёгочной ткани с обеднением лёгочного рисунка может наблюдаться: {

~%33,33333%при врождённой долевой эмфиземе

~%-100%при вирусной пневмонии

~%33,33333%при бронхиальной астме

~%33,33333%при инородных телах

}

При отёке лёгких имеет место рентгенологический симптом: {

~«голова акулы»

~«мишени»

=«крыльев бабочки»

~«слоёного пирога»

}

Линия «Демуазо» наблюдается при: {

=экссудативном плеврите

~раке лёгкого

~саркоидозе

~пневмонии

}

Застойные явления в лёгких рентгенологически проявляются: {

=сгущением и деформацией бронхососудистого рисунка:

~инфильтрацией верхних отделов

~пневмотораксом

~ателектазом

}

Для исследования позвоночника стандартными проекциями при рентгенографии являются: {

=прямая и боковая

~прямая и косая

~боковая и косая

~прямая

}

Какое количество физиологических сгибов определяется на боковой рентгенограмме позвоночника: {

=3

~4

~5

~2

}

Какой метод ультразвуковой диагностики применяют для измерения и визуализации скорости направления и характера движения крови в сосудах и камерах сердца: {

~эхография

~сонография

=доплерографию

~ангиография

}

Остеоденситометрию применяют: {

=для измерения минеральной плотности кости

~для измерения морфологической плотности кости

~для измерения минеральной плотности мягких тканей окружающих кость

~для измерения объема мягких тканей окружающих кость

}

К методам костной остеоденситометрии относятся: {

=рентгеновская абсорбционная и ультразвуковая денситометрия

~количественная магнитно-резонансная томография, и количественная компьютерная томография

~радионуклидная остеосцинтиграфия и сканирование

~термография

}

Лучевая нагрузка отсутствует при проведении: {

~рентгеновской абсорбциометрии скелета

~количественной компьютерной томографии

=количественной магнитно-резонансной томографической денситометрии

~радионуклидной остеосцинтиграфии

}

Нормальная головка бедренной кости имеет: {

=правильную круглую форму

~неправильную круглую форму

~овальную форму

~грибовидную форму

}

Межпозвоночные отверстия шейного отдела позвоночника лучше всего выявляются: {

~в прямой проекции

~в боковой проекции

~в проекции с поворотом 15 гр

=в проекции с поворотом 45 гр

}

Наиболее убедительным симптомом при распознавании переломов костей является: {

~уплотнение костной структуры

~деформация кости

=перерыв коркового слоя

~ линия затемнения

}

Из перечисленных соотношений между отломками проявляются уплотнением в области перелома: {

=вклинения отломков

~проекционная суперпозиция отломков при их захождении

~смещение отломков под углом

~расхождение отломков

}

Для переломов шейки бедренной кости не характерны: {

~смещение по длине с захождением отломков

~ротация наружу

=ротация внутрь

~смещение по углам открытым внутрь

}

Изменение кости и надкостницы при гематогенной остеомиелите у взрослых появляются в сроки: {

~7-10 дней

=2-3 недели

~1-1,5 месяца

~2 месяца

}

Чаще всего поражаются сифилисом: {

~позвонки

~бедренные кости

=большеберцовой кости

~тазовые кости

}

Злокачественным опухолям костей преимущественно поражающие лиц старше 50 лет относятся: {

~остеогенная саркома

=хондросаркома

~ретикулосаркома

~саркома Юнга

}

Слоистые периостальные реакции наиболее характерны: {

~для остеогенной саркомы

~для хондросаркомы

=для саркомы Юинга

~для фибросаркомы

}

Рентгенографию костей и суставов необходимо проводить в: {

~прямой проекции

~косой проекции

=двух взаимно перпендикулярных проекциях

~боковой проекции

}

На рентгенограммах неизменённой кости определяется надкостница: {

~в эпифизе

~в метафизе

=не определяется

~в диафизе

}

В каких случаях при травме костно-суставной системы используют МРТ: {

~для выявления линии перелома в трубчатой кости

~для дифференциальной диагностики патологического перелома позвонка

=при переломе тела и дуги позвонка для выявления с давления обломками спинного мозга и его корешков

~для определения костной мозоли

}

В каких случаях при травме костно-суставной системы не используют электрорентгенографию: {

=при массовых травматических повреждениях

~для оценки произведённой репозиции

~для контроля мозолеобразования

~для выявления посттравматических осложнений

}

При повреждении мениска и круглой связки в коленном суставе наиболее информативны: {

~рентгенография

~продольная томография

~компьютерная томография

=магнитно-резонансная томография

}

Наиболее ранним рентгенологическим признаком гематогенного остеомиелита являются: {

~%50%мелкоочаговая деструкция

~%-50%остеосклероз

~%-50%периостальная реакция

~%50%изменения в прилежащих мягких тканях

}

Наиболее частым осложнением гематогенного остеомиелита является: {

~эпифизеолит

~гнойный артрит
~озлокачествление
=свищ

}

Для доброкачественных опухолей и опухолевидных образований
внутрикостной локализации наиболее типичны: {

~нечёткие очертания
=чёткие очертания
~склеротический ободок
~широкий склеротический вал
}

Для хронического остеомиелита характерны: {

~%50%остеосклероз
~%50%секвестры
~%-50%деструкции
~%-50%изменения в мягких тканях
}

Для злокачественной опухоли кости не характерны: {

~дефект костной ткани с нечёткими контурами
=деструкция с чёткими контурами
~периостит в виде спикул
~периостит в виде козырька
}

Для злокачественной опухоли кости наиболее характерной является
периостальная реакция, проявляющаяся в виде: {

~% - 50% линейной тени
~%50% слоистого периостального наслоения:
~%50% периостального козырька
~% - 50% бахромчатого периостита
}

Опухолевое костеобразование имеет место при: {

=остеогенной саркоме
~саркоме Юинга
~миеломе
~метастазах рака предстательной железы
}

Раннее выявление метастатического поражение костей возможно с помощью:

{

~обычной рентгенографии
~томографии
=сцинтиграфии
~рентгенографии с прямым увеличением изображения
}

На этапах лечения перелома рентгенологический контроль проводится для: {

~подтверждения наличия перелома

=обнаружения вторичного смещения отломков и оценки костной мозоли
~вживления компрессии нервных стволов гематомы в зоне перелома
~по желанию родителей

}

Косвенные эхо признаки остеомиелита появляются: {

=ранее рентгенологических
~позже рентгенологических
~одновременно с рентгенологическими
~возможен любой вариант

}

Какая методика наиболее информативна при повреждении менисков: {

~рентгенограмма в 2 проекциях
~УЗИ исследование
~сцинтиграфия
=МРТ

}

Лучевой контроль состояние кости при остеомиелите проводится: {

=рентгенологически
~УЗИ
~КТ
~не проводится

}

Для исследования позвоночника стандартным проекции при рентгенографии являются: {

=прямая и боковая
~прямая и косая
~боковая и косая
~боковая

}

Какое количество физиологических изгибов определяется на боковой рентгенограмме позвоночника: {

=3
~4
~5
~2

}

Для исследования межпозвоночных дисков позвоночника «золотым стандартом» считают: {

~МСКТ
=МРТ
~КТ
~сцинтиграфию

}